Santé
Université de Paris

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Cours 10
UE n°7
Histoire, philosophie et éthique en santé

- *Responsable d'UE : Céline Lefève, Pr Marie-France Mamzer*
- *Enseignant : Léo Tertrais-Flamand*

Année universitaire 2026-27

Santé
Université de Paris

Cours 10 : Sociologie des inégalités sociales de santé

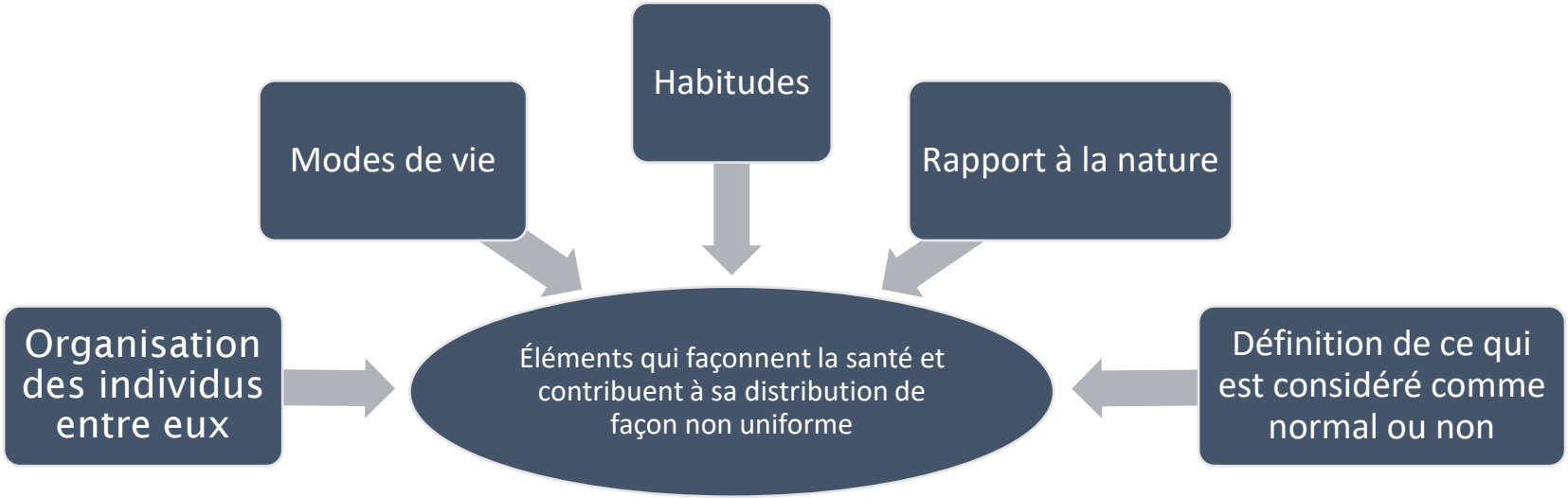
Introduction (1)

- Définitions de la santé et de la maladie **ne sont pas indépendantes des considérations sociales**
  - Hôpital (cf. cours 3)
  - XIXe (assurances) / XXe (sécurité sociale) : Renouvellement du lien entre action sociale et malades => maladie pensée comme relevant des aléas sociaux → protection nécessaire des travailleurs

Double action à la fois sanitaire et sociale qui détermine notre organisation administrative de la santé

Introduction (2)

- La santé appartient au **champ du social et pas seulement du biologique**
- Santé, maladie, mort : **différentes dimensions du monde social**



- **Def** Inégalités sociales de santé => selon le lieu où l'on vit, la place que l'on occupe dans la société, le métier qu'on exerce, la probabilité de contracter une pathologie déterminée est différenciée. De même, les soins prodigués et l'espérance de vue moyenne varient selon les groupes d'appartenance (profession, lieu de résidence, appartenance ethnique, genre)

Introduction (3)

➢ Les catégories sociales conditionnent
- le type de maladie
- l'espérance de vie
- la consommation de soins

→ inscription du social dans le corps des individus (corrélation entre taille, poids et appartenance sociale).

➢ Plan général (détaillé dans les diapos suivantes)

I. L'étude des inégalité sociales de santé dans les sciences sociales
II. L'exemple de l'obésité
III. L'accès aux soins dans le monde



I. L'étude des inégalité sociales de santé dans les sciences sociales

A. **Quelques éléments historiques**
B. Les causes sociales des inégalités de santé
C. Accroissement des inégalités sociales de santé et organisation de l'action

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(1)

- Conceptualisée à la fin du XVIIIe siècle → constat d'une mortalité différente suivant les couches sociales.
- Philosophie des Lumières + développement de la statistique => surmortalité de certaines catégories sociales.
- En France, dès le début du XIXe siècle, on tente de donner des explications aux inégalités de santé

- **Deux facteurs** :
  1. Manifestation exacerbée des inégalités sociales dues au capitalisme industriel triomphant dans un contexte urbain qui s'est fortement développé
  2. Préoccupation des scientifiques auxquels on s'adresse pour étudier la condition de vie des ouvriers et de leurs familles (soucis de réformisme + contrôle social + mise en pratique des idées hygiénistes naissantes : santé => élément essentiel du progrès moral)

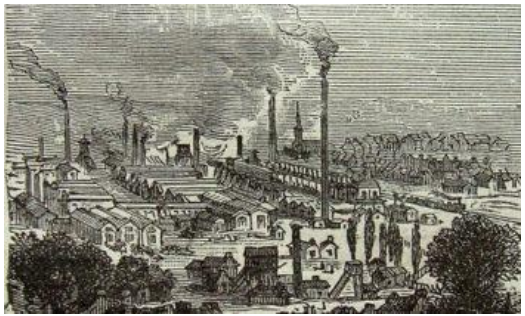
I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(2)

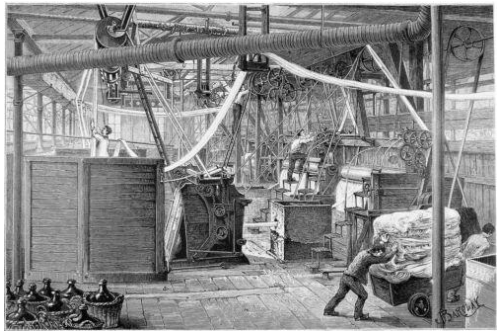
- **Deux facteurs (développement)**

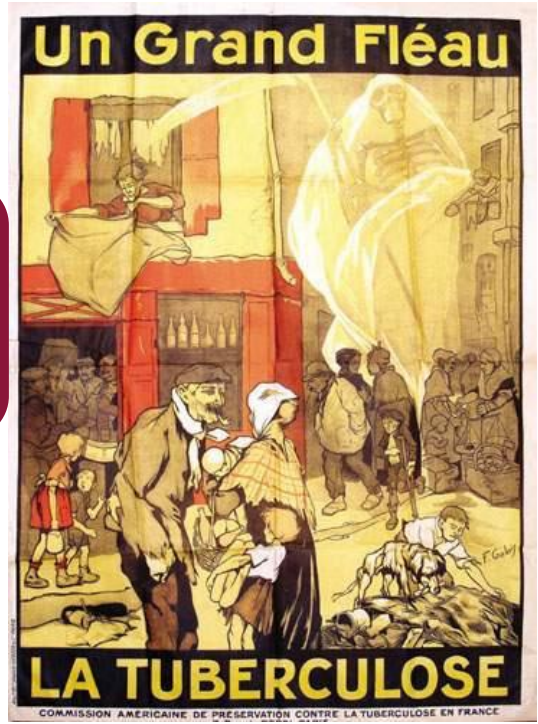
1er Facteur : Industrialisation + urbanisation = concentration de population dans les villes

Révolution industriel → Exode rural → Entassement dans des logements insalubres → Milieu et conditions de travail

Influence sur la santé et sur la diffusion de certaines maladies (fléaux sociaux)
Ex : Tuberculose, Syphilis







I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(3)

2e facteur :

Hygiénisme : « science qui a pour but l'amélioration des conditions de la vie humaine par l'application administrative des règles d'hygiène et de la santé publique ».

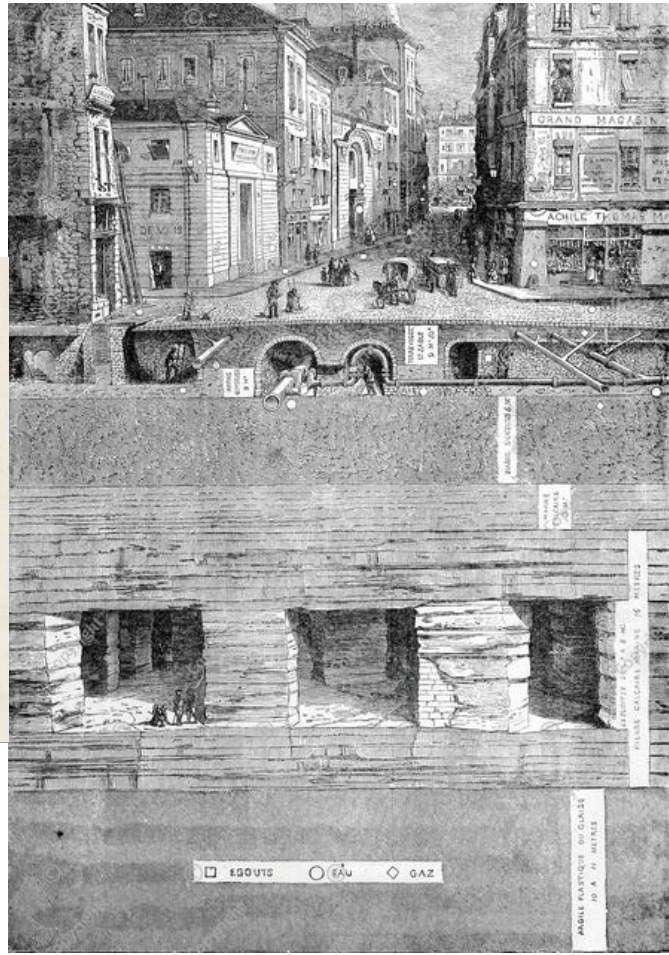
Hygiène : « science qui nous enseigne les moyens de **conserver** et d'**améliorer** notre santé, **d'éviter les maladies** et de vivre le plus longtemps possible. L'hygiène est donc après la morale qui nous apprend nos devoirs et nos droits, la plus utile de toutes nos sciences, celle dont personne ne devrait ignorer les principes. » Dr Armaingaud, président de la ligue française contre la tuberculose, 1895.

=> Développement de l'hygiène publique en France première moitié du XIXe siècle = **organisation de la société selon les principes de l'hygiènes porté par les hygiénistes** (médecins, architectes, hommes politiques)

Hygiène devient un savoir social qui agit sur l'espace public



Exemple brochure de prévention



Exemple aménagement urbain =>

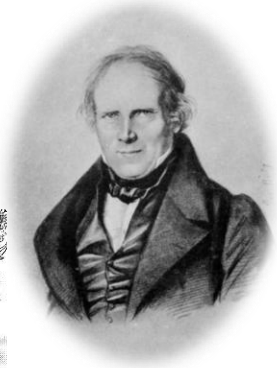
I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(3)

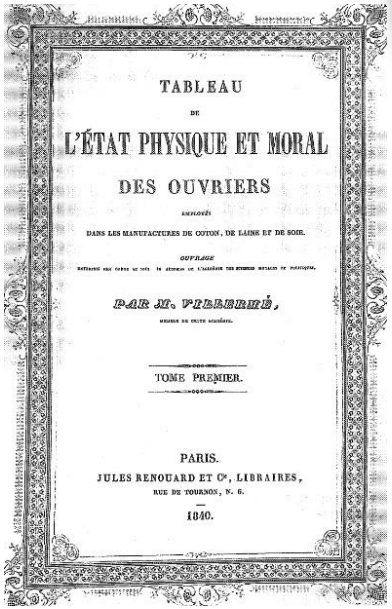
Ex d'observation de ces fléaux sociaux :

- Louis René Villermé (médecin, observateur de la condition ouvrière)
- étude des relations entre mortalité et pauvreté dans différents quartiers de Paris + problèmes de santé des ouvriers du textile
- Publication en 1840 de *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie*
- Constats argumentés des inégalités de santé qui se produisent ainsi en regard de **l'industrialisation et de ses effets sur le corps des individus**.

→ Avant ça : idée que la durée de vie était la même pour tous

→ Approche populationnelle plutôt qu'individuelle




TABLEAU

DE

L'ÉTAT PHYSIQUE ET MORAL

DES OUVRIERS

EMPLOYÉS

DANS LES MANUFACTURES DE COTON, DE LAINE ET DE SOIE.

OUVRAGE

PAR M. VILLERMÉ,

TOME PREMIER.

PARIS.

JULES RENOUARD ET Cie, LIBRAIRES,

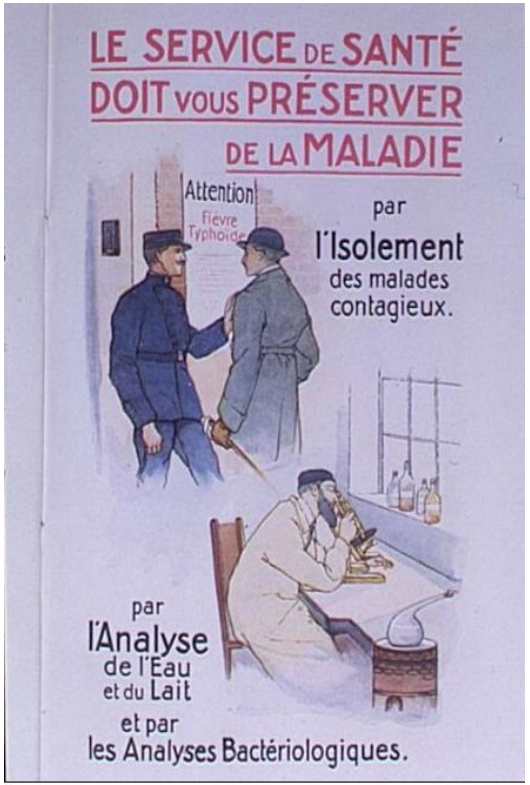
RUE DE TOURNON, N. 6.

1840.

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(4)

Révolution bactériologique : rôle important dans la reconfiguration de la prévention.

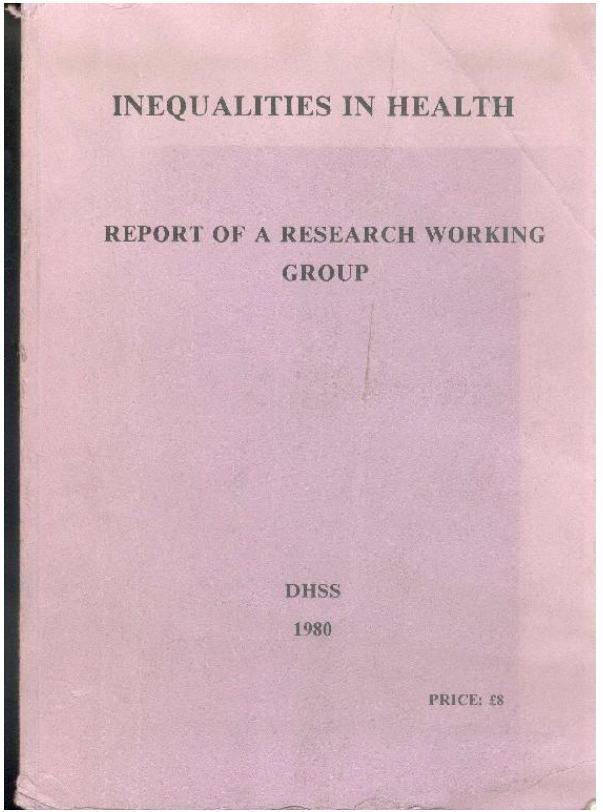
→Identification des germes responsables des maladies permet de fonder ou invalider l'aménagement de l'environnement et des pratiques sociales.



e gallicaintramuros.bnf.fr / Bibliothèque nationale de Fr

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(5)

- Retard français par rapport à la Grande-Bretagne
- France : faible culture épidémiologique et de santé publique + une politique de remboursement centrée sur l'offre
- NHS (National Health Service) britannique : gratuité → population cible déterminées pour organiser la répartition des allocations de ressources.
- *Le Black Rep*ort 1980 : sur le demi-siècle écoulé : accroissement fort de l'espérance de vie pour toutes les catégories sociales et tendance à l'augmention des inégalités malgré l'amélioration générale des conditions de vie et l'instauration d'un accès égalitaire au système de soins.
- **Gradient social de santé :** inégalités tout au long de l'échelle sociale



I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / A. Quelques éléments historiques(6)

- Cohorte de Whitehall – étude épidémiologique
- Inégalités sociales de santé : touchent l'ensemble de la population et non plus seulement des catégories extrêmes -> **mode de lecture du social**.
- Ouverture d'un champ de recherche économie, sociologie, épidémiologie, santé publique
- France plus tardif : recherches à partir des années 1990
- **Idée fausse** => les progrès médicaux et l'amélioration des conditions de vie se traduiraient mécaniquement par une diminution des inégalités
- Différence de considération concernant les maladies (biologique et individuel)

I. L'étude des inégalité sociales de santé dans les sciences sociales

A. Quelques éléments historiques

B. Les causes sociales des inégalités de santé

C. Accroissement des inégalités sociales de santé et organisation de l'action

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (1)

- Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes : pas seulement une différence biologique mais aussi d'une différence sociale
- **Distinction** : sexe (biologique) / genre (social).
- Femmes : taux de morbidité supérieurs à ceux des hommes (plus fréquemment, mais moins gravement, malades).
- Inégalités sociales de santé : plus importantes chez les hommes que chez les femmes.
- Espérance de vie des hommes « cadre » dans les années 1990 > 7 ans à celle des ouvriers, (écarte de 3 ans entre les femmes « cadres » et les ouvrières).
- Le genre, la catégorie professionnelle, le niveau de revenu, le niveau d'éducation, le lieu de résidence → **critères sociaux qui conditionnent le niveau de santé et l'espérance de vie.**

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (2)

- Diminution des inégalités de santé entre hommes et femmes ces dernières années
- **MAIS** => celles qui prévalent entre catégories professionnelles sont plutôt en augmentation
- Élucidation des causes sociales des inégalités de santé = complexe du fait du **grand nombre de facteurs potentiellement impliqués**.
- Quatre dimensions de facteurs :
- 1) les conditions matérielles de vie des individus, très largement liées à leur revenu et à leurs ressources économiques.
- 2) l'environnement social et physique : les conditions de logement, le lieu de résidence, les nuisances environnementales, mais aussi les conditions de travail.
- 3) les pratiques et les comportements liés à la santé, comme l'alimentation, le tabac, la consommation d'alcool, l'activité physique ou les pratiques de prévention.
- 4) il faut aussi prendre en compte les rapports au système de soins, la manière dont les individus y accèdent et la qualité de leur prise en charge.

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (3)

1/ **Conditions matérielles de vie des personnes** : lié au revenu économique (logement, alimentation).

→ **Effet tout au long de la vie** (conditions de vie particulière dans l'enfance => influence sur l'état de santé quelques années plus tard)

- **Capital économique** : niveau de consommation médical (assurance maladie, complémentaire) : certains délaissent les soins de base (renonce pour des raisons financières).
- Des dispositifs tels que la Couverture médicale universelle (CMU), Aide Médicale Gratuite (AME) : ouvrent en partie le système de santé aux plus défavorisés **mais** insuffisant pour réduire les inégalité : stigmatisation, sentiment de honte, méconnaissance par les ayant droit et les pro. de santé

=> Un dispositif règlementaire ne suffit pas à produire de l'équité

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (4)

2/ **Environnement social** : corrélé aux conditions matérielles : expose à (ou protège) des risques spécifiques en santé

a) Environnement de vie (zones de pollution, déserts médicaux)

b) Environnement de travail (substances, bruit, rythme décalé, postures…), nuisances psychologiques (stress, manque de reconnaissance, absence d'autonomie) => Pénibilité du travail

Facteurs protecteurs : satisfaction intellectuelle, adéquation poste/compétences, travail valorisé

- Touche les personnes socio-économiquement les plus fragiles : insécurité, précarisation de l'emploi et absence de travail

=> **sur-morbidité et une surmortalité des chômeurs et des inactifs** : exclusion du monde du travail générant une dévalorisation personnelle, un sentiment d'inutilité sociale et un isolement social

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (5)

=> Degré d'insertion sociale et de sociabilité, son inscription et sa participation aux différentes sphères de la vie sociale => fort impact sur la santé

- Importance des **conduites individuelles dites « à risques »** : la consommation de tabac, d'alcool, l'alimentation (pas strictement individuels car fortement corrélés aux catégories sociales).
- Interprétation de ces conduites à risque comme une **moindre attention portée à sa santé** chez les personnes en situation de vulnérabilité sociale => concentration sur leurs difficultés économiques, d'accès au logement et d'insertion sur le marché du travail, sur lesquelles elles se concentrent prioritairement.

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / B. Les causes des inégalités sociales (6)

- **Couches sociales favorisées consultent plus précocement**
- Plus observantes sur le plan préventif (dépistages, activités sportives)
- Fréquentation et connaissance du monde de la médecine, de la santé et du mieux-être → **meilleure qualité de soins** (accès rapide aux innovations médicales et aux nouvelles informations de prévention et orientation plus facile vers les professionnels spécialistes
- **Proximité socio-culturelle des médecins**, partageant ainsi les mêmes normes et référents sociaux, notamment langagiers → **compréhension réciproque dans la rencontre médicale**.
- Santé également comme cause d'inégalité sociale (pas uniquement conséquence) : problèmes spécifiques (maladie, handicap, etc.) peuvent eux-mêmes constituer un facteur de baisse de revenu, de moindre niveau d'éducation et de niveau social.

I. L'étude des inégalité sociales de santé dans les sciences sociales

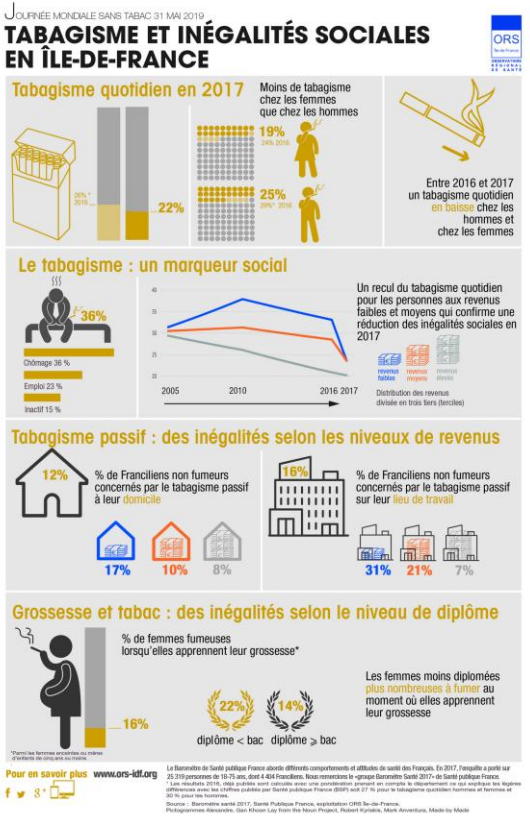
A. Quelques éléments historiques
B. Les causes sociales des inégalités de santé
C. Accroissement des inégalités sociales de santé et organisation de l'action

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / C. Accroissement des inégalités sociales de santé et organisation de l'action (1)

- Aujourd'hui : bien documenté => intégration dans les plans de santé publique.

Ex :

- Savoirs sur les méfaits du tabac sur la santé se sont traduits par une baisse de la consommation bien plus marquée chez les cadres que chez les ouvriers.
- Campagnes d'information pour une alimentation plus riche en fruits et légumes →différenciation accrue des modes alimentaires selon les catégories sociales encore renforcée par l'aspect économique de la question.



Ne pas apprendre les éléments de l'image =>

I. L'étude des inégalités sociales de santé dans les sciences sociales / C. Accroissement des inégalités sociales de santé et organisation de l'action (2)

- Les inégalités sociales de santé sont toujours présentes. Il est important d'en avoir conscience et de les comprendre comme futurs professionnels de santé et citoyens.
- Elles ont une incidence sur l'exposition aux maladies de manière différenciée, donc sur : l'accès aux soins, les diagnostics, les possibilités te traitement, mais aussi sur les moyens de prévention à mettre en place et leur réception.

Exemple =>

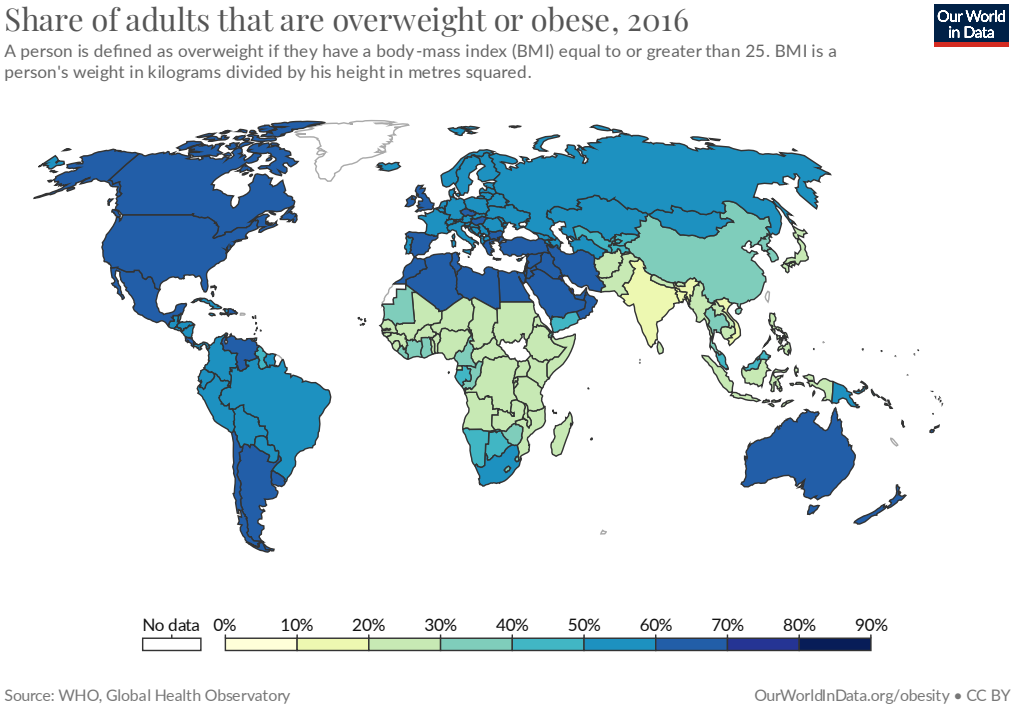


II. L'exemple de l'obésité

A. **Origines sociales d'une épidémie mondiale**
B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité
C. La corpulence comme déterminant des statuts économiques et sociaux

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (1)

- 2000, OMS : obésité = « épidémie mondiale ».
- 2016 : estimation à l'échelle de la planète = 1,9 milliard d'adultes (âgés de 18 ans et plus) en surpoids et au moins 650 millions d'adultes obèses, auxquels il convient d'ajouter les enfant : « au moins 38 millions d'enfants de moins de 5 ans en surpoids » (2019).
- **Obésité = question globale.**



Ne pas apprendre les éléments de l'image =>

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (2)

- **International : consensus sur la différenciation sociale de l'obésité de l'adulte depuis la fin des années 1990**
- Fin années 80 : méta-analyse de 144 études (Jeffrey Sobal, sociologue de l'alimentation et de la nutrition, Albert J. Stunkard, psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et l'obésité) : **différences entre pays développés et en voie de développement** :
  - **En voie de développement** : Homme et femmes, haut de l'échelle sociale : trois causes principales = (1) malnutrition pour une partie importante de la population → plus grande disponibilité alimentaire dans les milieux aisés. (2) travail et conditions de vie ne nécessitent pas de dépenses énergétiques importantes (3) système de représentation : valorisation des corpulences fortes associées à une certaine aisance et s'inscrivent dans l'univers du désirable.
  - **Sociétés développées :** inverse → plus fréquemment dans les couches populaires et dans le bas de l'échelle sociale. Ce phénomène est statistiquement très lisible pour les femmes et beaucoup moins net pour les hommes. Mouvement de basculement d'une obésité masculine « distinguée », présente dans les couches sociales aisées, dominante avant les années 1960, qui correspondait à l'image de l'homme d'affaires « installé dans la vie », vers une obésité masculine « populaire », plus fréquente dans les études contemporaines.

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (3)

France, plusieurs études épidémiologiques :

- une différenciation sociale et économique de la prévalence de l'obésité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes (ObÉpi, 2003 ; Nutrialis, 2003).
- taux de prévalence les plus élevés dans les milieux les moins favorisés.

=> **Travaux sociologie de la santé** : les liens entre l'obésité et les dynamiques sociales intergénérationnelles et intragénérationnelles, les prévalences les plus fortes étant associées à des dynamiques descendantes, c'est-à-dire à des dégradations de position sociale (Poulain, 2001 b ; Poulain et al., 2003 a).

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (4)

- Enfants : (métaanalyse de Sobal et Stunkard 1988)

Situation différente :

- **Sociétés en développement** : tous les jeunes obèses sont issus des groupes sociaux les plus élevés.
- **Sociétés développées** : pas de régularité entre les positions sociales des parents et la prévalence de l'obésité des enfants. **MAIS** évolution depuis la fin des années 1980 vers un statut économique faible des parents

France

- Etude Inca 1998-1999 de 3 à 14 ans : de 7 % cadres etc./ 25 % chez les enfants de chômeurs .
- Étude De Perreti 2004 : prévalence de l'obésité de 0,7 % (cadres) à 7,4 % (ouvriers non qualifés) / surpoids, obésité incluse, de 10,8 % à 22,4 %
- Nord de la France, (Monique Romon et al., 2005), compare 1989 et 1999 : augmentation de la prévalence pour les enfants issus de l'ensemble des catégories sociales, à l'exception de ceux de familles de cadres et de professions libérales.
- (NE PAS APPRENDRE LES CHIFFRES MAIS COMPRENDRE LA TENDANCE)

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (5)

- Adolescents : études rares.
- Une recherche réalisée dans trois départements français sur une population de 10 à 18 ans montre une prévalence de 2,6 % pour l'obésité, de 15,3 % pour l'excès de poids (regroupant l'obésité et le surpoids) et donc de 12,7 % de surpoids (Feur et al., 2003).
- L'étude met en évidence des liens entre des structures familiales où un seul parent travaille à temps partiel (21,2 % contre 15,6 %), où le budget alimentaire « pose problème » (20,1 % contre 15,6 %) et où l'adolescent n'est pas parti en vacances l'été précédent (19,9 % contre 14,3 %).
- Tableau parcellaire **mais** ces constatations renforcent l'hypothèse de l'influence de déterminants sociaux dans le développement de l'obésité de l'enfant.
- (NE PAS APPRENDRE LES CHIFFRES MAIS COMPRENDRE LA TENDANCE)

II. L'exemple de l'obésité / A. Origines sociales d'une épidémie mondiale (6)

Déterminants sociaux de l'obésité :

- Constat du développement et de la différenciation sociale de l'obésité
- Comment les déterminants sociaux peuvent-ils avoir un impact sur la santé ?

L'influence des déterminants sociaux sur le développement de l'obésité peut être envisagée selon deux chaînes de causalité, à la fois distinctes et complémentaires :

a) les statuts et les dynamiques sociales peuvent être considérés comme déterminants de l'obésité

b) l'obésité, et plus largement la corpulence, peut également être vue comme influençant les positions et les dynamiques sociales.

→ **double chaîne de causalité**.

II. L'exemple de l'obésité

A. Origines sociales d'une épidémie mondiale

B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité

C. La corpulence comme déterminant des statuts économiques et sociaux

II. L'exemple de l'obésité / B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité (1)

Impact des positions sociales sur les pathologies s'opère principalement, mais non exclusivement, par les modes de vie :

→ styles d'alimentation (les préférences, les goûts et les pratiques alimentaires)

→ niveau d'activité physique

→ Influence secondaire d'autres facteurs sociaux comme le stress, l'exclusion sociale, le chômage, l'absence de soutien social, etc.

→ Influence du social sur le physiologique

II. L'exemple de l'obésité / B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité (2)

- Modèle thermodynamique : obésité = écart entre les apports alimentaires et les consommations d'énergie.
- Dans les sociétés modernes : baisse des les dépenses énergétiques en raison des modifications des modes de vie depuis une soixantaine d'années
- La baisse de consommation se serait opérée de façon socialement diversifiée

- Différenciation sociale des goûts, qui se traduit par une survalorisation « de l'énergétique », « du puissant », « du fort » dans les milieux populaires => « revanche sociale ».
- Niveau et conditions d'appropriation de l'information nutritionnelle : intérêt porté à la nutrition varie en fonction du niveau social et du sexe => femmes plus sensibles que les hommes, plus diplômés, plus réceptifs. => **la disposition d'un stock d'informations nutritionnelles ne se traduit pas toujours par des transformations dans les comportements**

II. L'exemple de l'obésité / B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité (3)

Paramètres biologiques:

- **transformations structurelles et organisationnelles des sociétés modernes**, et de leur impact sur les systèmes d'action concrets de la filière alimentaire (de l'industrialisation de l'alimentation et des systèmes d'approvisionnement, à la concentration des formes de distribution, au développement de la restauration hors foyer, jusqu'aux formes d'urbanisation des cités modernes) ;
- **des mutations des systèmes de représentations sociales** relatifs à l'alimentation et à l'image du corps.

→ Ces transformations des systèmes d'action des acteurs sociaux et de l'imaginaire social pourraient avoir, directement ou indirectement, un impact sur les modes de vie et donc sur le développement de l'obésité.

II. L'exemple de l'obésité

A. Origines sociales d'une épidémie mondiale
B. Les statuts économiques et sociaux déterminants de l'obésité
C. La corpulence comme déterminant des statuts économiques et sociaux

II. L'exemple de l'obésité / C. La corpulence comme déterminant des statuts économiques et sociaux (1)

- **Inversion de la perspective : les systèmes de valeurs associés à la corpulence déterminent partiellement les statuts économiques et sociaux**
- **Stigmatisation** : résultat du système de valorisation culturelle de certaines formes de corpulence et des processus de définition des normes sociales relatives au corps qui désignent comme « déviants » des individus qui s'en éloignent.
  - Conséquences objectives : discriminations,
  - Conséquences subjectives : estime de soi des personnes stigmatisées.

→ Impact sur les trajectoires sociales + développement de l'obésité (désocialisation)

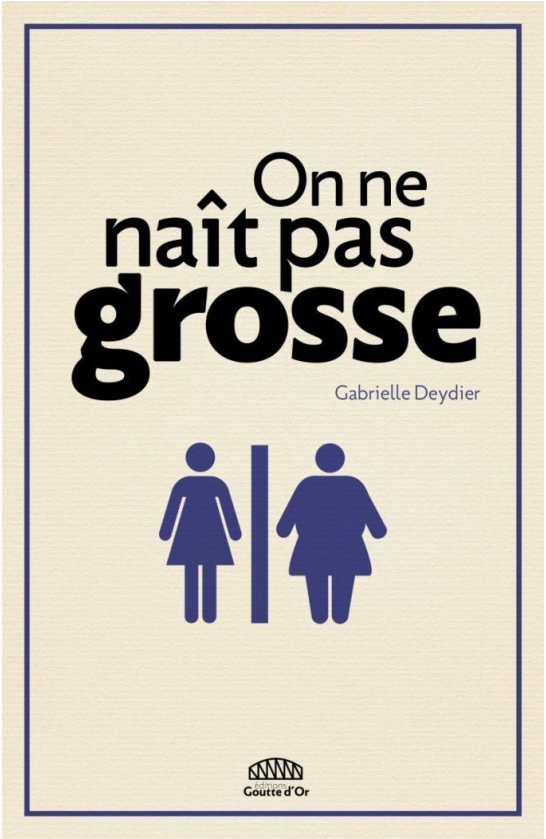
→ Affecte le parcours scolaire, l'accès à l'emploi, la trajectoire professionnelle → influence sur la position sociale de l'individu.

Conséquences de la stigmatisation : effets d'aggravation de l'obésité (INSERM, 2005).

→ Facteur de risque social + risques sanitaires identifiés par l'épidémiologie et interagit avec eux.

II. L'exemple de l'obésité / C. La corpulence comme déterminant des statuts économiques et sociaux (2)

- Stigmatisation et les systèmes de : idéal de minceur => Effets directs sur les obèses ou les personnes en surpoids, mais aussi des effets d'anticipation sur les sujets non obèses, en les alertant sur le sort qui risque d'être le leur s'ils « deviennent comme cela ».
- Pratiques d'amaigrissement sans justification sanitaire qui peuvent se révéler à terme impliquées dans le développement de troubles du comportement alimentaire.
- La chaîne de causalité peut donc s'inverser, la corpulence devenant dès lors un déterminant des statuts économiques et sociaux.



III. L'accès au soin dans le monde

A. **Des inégalités cumulative**

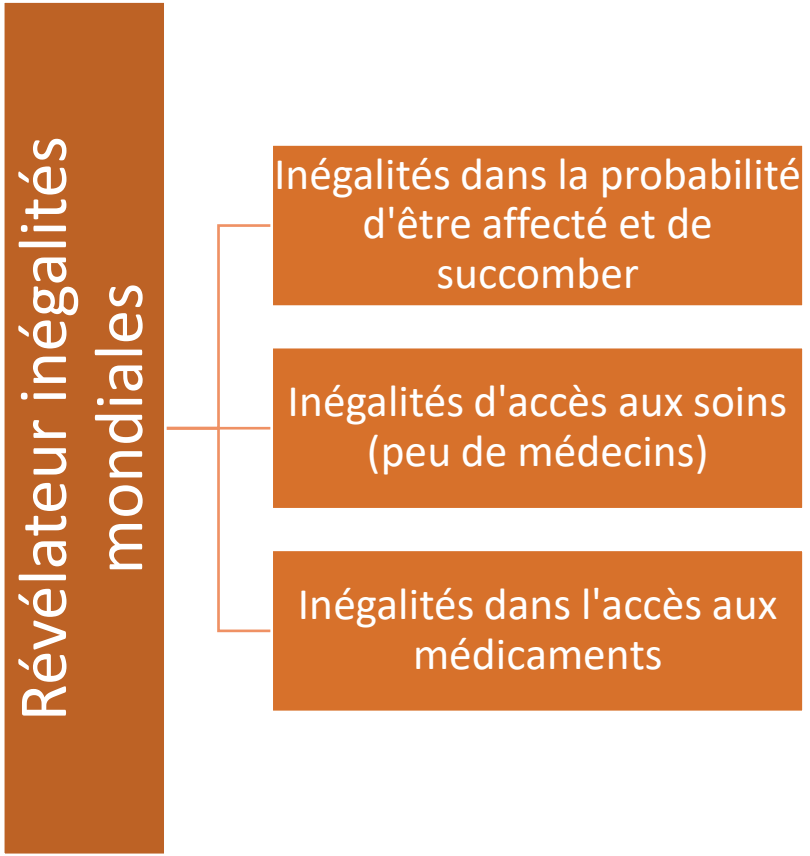
B. La prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé

III. L'accès aux soins dans le monde / A. Des inégalités cumulatives (1)

- 2013-2015 : Ebola Afrique de l'Ouest : 10 000 décès (pour 25 000 cas)
- Inégalités dans les traitements médiatiques et politique (août 2014 : OMS déclare Ebola comme une « urgence de santé publique de portée mondiale »)

⇒ Lutte contre les inégalités mondiales : priorité des organisations sanitaires internationales

⇒ Inégalités cumulatives



III. L'accès aux soins dans le monde / A. Des inégalités cumulatives (2)

- Amélioration de la situation sanitaire mondiale durant le XXe siècle.
- Le taux de mortalité infantile : 90 décès pour 1 000 naissances en 1990 chez les enfants de moins de cinq ans et s'élève désormais à 48 décès pour 1 000 naissances.
- En Afrique subsaharienne par exemple, le taux de mortalité des moins de cinq ans reste de 98 ‰, soit 15 fois plus en moyenne que dans les pays développés.
- L'espérance de vie à la naissance est de 47 ans au Malawi et de 83 ans au Japon, mais aussi à l'intérieur des pays, en fonction des conditions de vie des individus et des groupes sociaux.

III. L'accès aux soins dans le monde / A. Des inégalités cumulatives (2)

- **Plusieurs échelles d'inégalités : économiques, sociales et politiques**

- Progrès sanitaires en Europe à partir de la fin du XIXe siècle : **pas seulement dus aux découvertes scientifiques et à la révolution microbiologique, mais aussi à la mise en place de réformes sanitaires et sociales visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres, puis à la création de systèmes de sécurité sociale.**

III. L'accès aux soins dans le monde / A. Des inégalités cumulatives (3)

- « fléaux sociaux » → inégalement répartis à la surface du globe (95 % des décès liés à la tuberculose surviennent dans les pays en développement par exemple),
- Existence d'une « transition épidémiologique » ne doit pas être surestimée.
- Les pays du Sud sont également touchés par les maladies dites chroniques (60 % des nouveaux cas de cancer et 70 % des décès ont lieu dans les pays en développement) et les maladies infectieuses sont bien présentes dans les pays du Nord (VIH/sida, SRAS, grippe aviaire…).

→ L'accroissement des interdépendances, donc de la circulation des virus et des modes de vie, ne fait que renforcer l'unité microbienne et sanitaire du monde. Face à cela, la capacité des populations à maintenir un bon état de santé dépend avant tout de leur accès aux soins et aux médicaments.

III. L'accès au soin dans le monde

A. Des inégalités cumulative

B. La prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé

III. L'accès aux soins dans le monde / B. Prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé (1)

- Premières organisations sanitaires internationales : Office international d'hygiène publique, Organisation d'hygiène de la Société des Nations… --> concentration sur le contrôle des maladies et la prévention des épidémies.
- Les inégalités sanitaires entre pays comprises comme le reflet de la dépendance entre la métropole et les territoires coloniaux
- Médecine coloniale : amélioration sanitaire vue comme un moyen de développement économique des colonies

III. L'accès aux soins dans le monde / B. Prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé (2)

- Réorganisation du système sanitaire international après la Seconde Guerre mondiale autour de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (1948)
- Années 1970 : réduction des inégalités sanitaires mondiales devient une préoccupation centrale.
- L'OMS s'engage pour un « nouvel ordre sanitaire international », esquissé par la déclaration de Alma-Ata de 1978 sur l'« accès à la santé pour tous en l'an 2000 » et centré autour du lancement d'une nouvelle stratégie dite des « soins de santé primaires ».

→ **Nouvelle orientation** : épuisement des approches « verticales » en vigueur auparavant, fondées sur une conception étroite et technique des maladies ne prenant pas en compte l'environnement économique et social dans lequel vivent les populations.

III. L'accès aux soins dans le monde / B. Prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé (2)

- À partir des années 1970, intérêt de l'OMS = « **déterminants de la santé** » (les conditions dans lesquelles vivent les populations : logement, agriculture, éducation…)
- **Liste de médicaments essentiels** que les pays sont invités à se procurer en priorité.
- Années 1990 et 2000 : pandémie du VIH/sida → importante mobilisation transnationale
- L'explosion des financements dans le domaine de la santé mondiale
- Importance de la santé dans les Objectifs du millénaire pour le développement reflètent les efforts entrepris dans ce domaine.

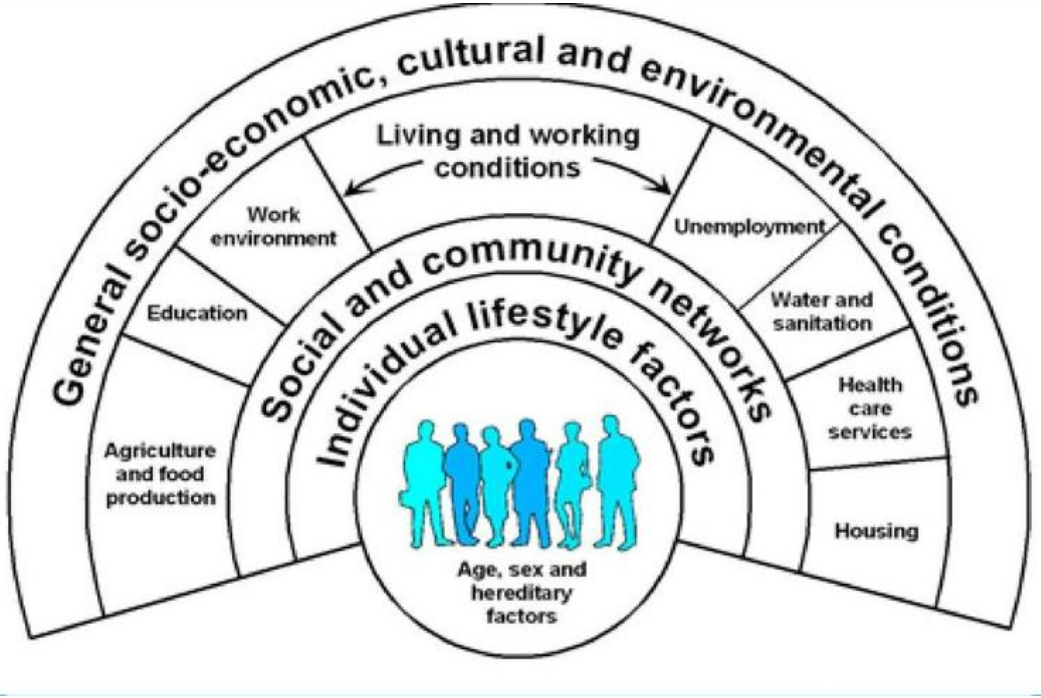
→ La réduction des inégalités sanitaires est en effet au cœur de ces huit objectifs adoptés en 2000 et censés être atteints en 2015 : réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies et rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement.

III. L'accès aux soins dans le monde / B. Prise en compte progressive des déterminants sociaux de santé (3)

- 2005 : OMS → commission des déterminants sociaux de la santé : 2012 la déclaration politique de Rio.

→ Réaffirmation des objectifs de la conférence d'Alma-Ata par la communauté internationale et **engagement à combattre les causes sociales des problèmes de santé et des inégalités sanitaires.**

→ Une grande partie des efforts à fournir pour réduire les inégalités en matière de santé doit intervenir dans le **domaine extra-sanitaire** et nécessite de « lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources »



Conclusion

- La santé et la maladie peuvent être appréhendées autrement que par leurs aspects biologiques et psychologiques. Les travaux des sociologues permettent de rendre visible leur dimension sociale.
- Les inégalités sociales de santé : révèlent le caractère socialement construit des états de santé.
- Différences importantes et systématiques entre les groupes sociaux ne peuvent pas s'expliquer par des variations biologiques interindividuelles, ni par des événements accidentels de la vie.
- Les sociologues montrent de quelle manière l'organisation sociale elle-même est productrice d'états de santé inégaux.
- Lutter contre les inégalités de santé ne relève pas seulement du système de soins, mais de politiques économiques, environnementales et sociales.